



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PROGRAM KERJA
KOMITE KEPERAWATAN
TAHUN 2026**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang
Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874
Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2

BAB I 3

PENDAHULUAN 3

 1.1 Latar Belakang 3

 1.2 Dasar Hukum 3

 1.3 Tujuan 3

BAB II 5

GAMBARAN UMUM 5

 2.1 Visi 5

 2.2 Misi 5

 2.3 Motto 5

 2.4 Landasan 7 Nilai Budi Utama 5

 2.5 SOTK 6

BAB III 8

KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN 8

 3.1 SDM 8

 3.2 Pengembangan Pelayanan 9

 3.3 Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan 9

 3.4 Sasaran 11

 3.5 Cara Melaksanakan Kegiatan 16

 3.6 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Komite Keperawatan Tahun 2026 21

 3.7 Kebutuhan Anggaran 22

BAB IV 24

MONITORING DAN EVALUASI 24

 8.1 Monitoring 24

 8.2 Evaluasi 24

BAB V 25

PENCATATAN DAN PELAPORAN 25

BAB VI 26

PENUTUP 26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Program Kerja Komite Keperawatan Tahun 2025 telah menjadi dasar penting dalam penguatan tata kelola keperawatan di rumah sakit. Selama tahun 2025, Komite Keperawatan bersama Sub Komite Kredensial, Mutu Keperawatan, serta Etik dan Disiplin telah melaksanakan berbagai kegiatan yang berfokus pada pemenuhan regulasi, penataan kewenangan klinis, pelaksanaan kredensial dan rekredensial perawat, peningkatan mutu pelayanan, serta pembinaan etik dan profesionalisme keperawatan.

Hasil evaluasi pelaksanaan program kerja tahun 2025 menunjukkan bahwa secara umum kegiatan telah berjalan sesuai perencanaan dan mendukung operasional pelayanan keperawatan. Namun demikian, evaluasi juga mengidentifikasi adanya kebutuhan untuk meningkatkan kesinambungan antara kegiatan kredensial, pelatihan, mutu pelayanan, dan pembinaan etik agar lebih terintegrasi dan berdampak langsung terhadap praktik klinis perawat.

Berdasarkan temuan tersebut, Program Kerja Komite Keperawatan Tahun 2026 disusun sebagai kelanjutan dan penguatan dari program kerja tahun sebelumnya, bukan sebagai perubahan arah kebijakan. Fokus pengembangan tahun 2026 diarahkan pada peningkatan integrasi antar sub komite melalui penyelarasan kewenangan klinis, pelatihan berbasis risiko pelayanan, monitoring mutu keperawatan, serta pembinaan etik yang terdokumentasi secara sistematis.

Sebagai bentuk peningkatan tata kelola, Program Kerja Tahun 2026 menekankan pemanfaatan logbook terintegrasi sebagai instrumen utama untuk menghubungkan proses kredensial, pelaksanaan praktik klinis, evaluasi mutu, penerapan etik, dan pengembangan kompetensi perawat secara berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, setiap kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga dapat ditelusuri dampaknya terhadap mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Dengan demikian, Program Kerja Komite Keperawatan Tahun 2026 diharapkan mampu memperkuat kesinambungan pembinaan keperawatan, meningkatkan profesionalisme perawat, serta mendukung pencapaian mutu pelayanan rumah sakit secara menyeluruh dan berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Permenkes No. 49 Tahun 2013 Tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit.
4. Permenkes No. 26 Tahun 2019: Peraturan pelaksanaan yang terkait dengan perizinan dan praktik keperawatan.

1.3 Tujuan

1. Tujuan Umum

Meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan serta mengatur tata kelola klinis yang baik agar mutu pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan yang berorientasi pada keselamatan pasien di Rumah Sakit lebih terjamin dan terlindungi.

2. Tujuan Khusus

Meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan yang bekerja di Rumah Sakit dengan cara:

- a. Melakukan kredensial bagi seluruh tenaga keperawatan yang akan.
- b. melakukan pelayanan keperawatan dan kebidanan di Rumah Sakit.
- c. Memelihara mutu profesi tenaga keperawatan.
- d. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesi bidan dan perawat.
- e. Menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi perawat dan bidan.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Visi

Rumah Sakit Prima Husada memiliki visi :

“ Menjadi rumah sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat.”

2.2 Misi

Rumah Sakit Prima Husada memiliki misi :

1. Memberikan pelayanan Kesehatan dengan aman, tepat, cepat, dan akurat.
2. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien.
3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan.

2.3 Motto

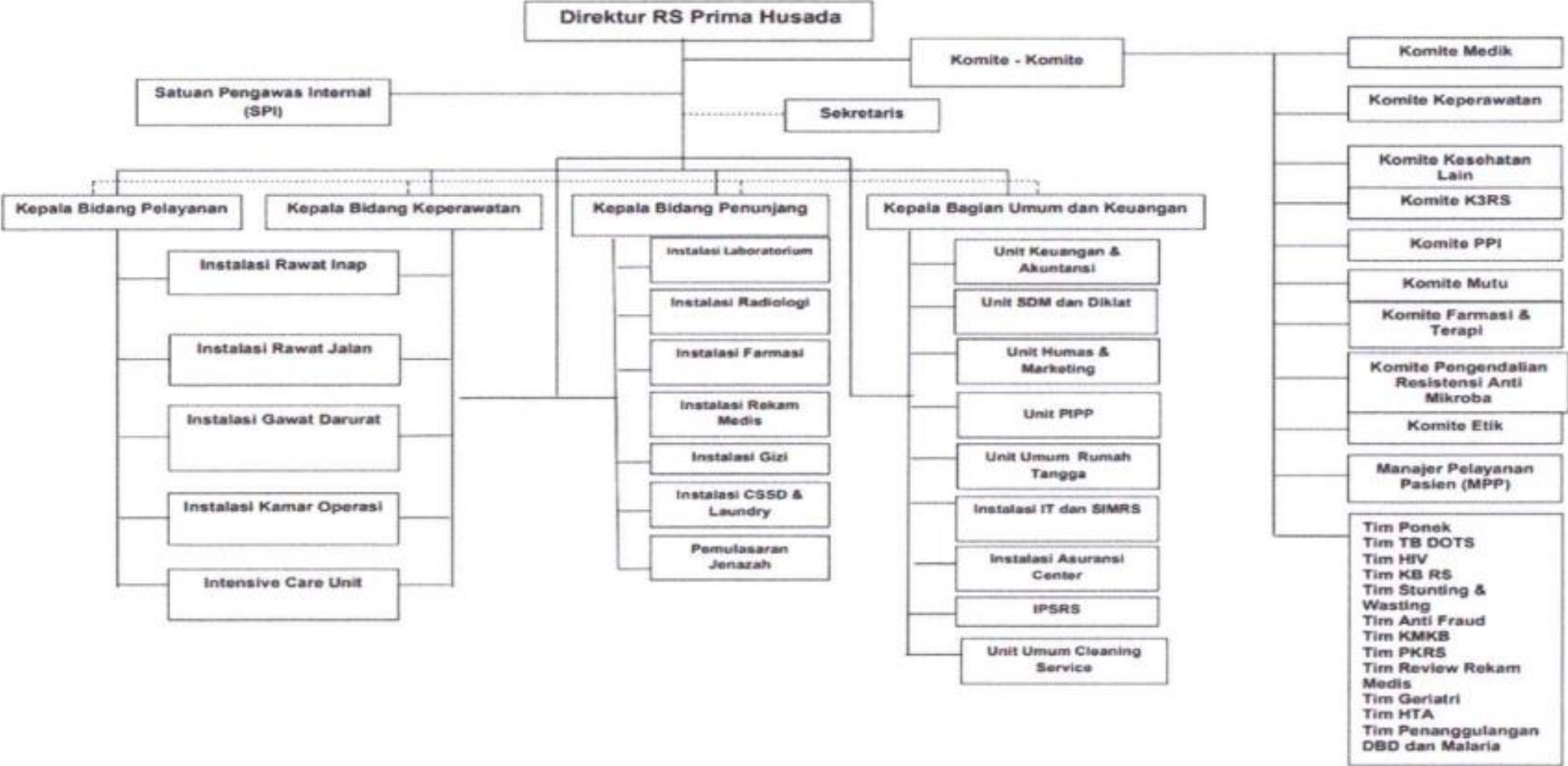
“Sahabat Menuju Sehat”

2.4 Landasan 7 Nilai Budi Utama

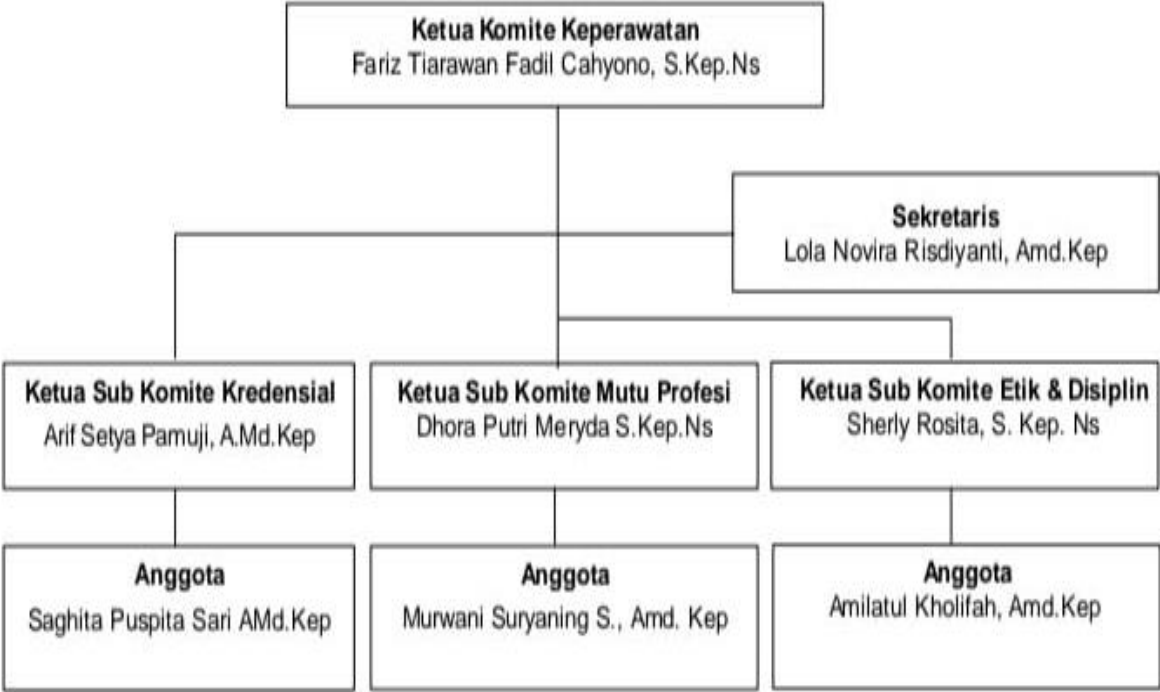
Rumah Sakit Prima Husada memiliki Landasan 7 Nilai Budi Utama :

1. Jujur dan dipercaya
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli

2.5 SOTK



SUSUNAN KOMITE KEPERAWATAN
RS PRIMA HUSADA



BAB III
KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN

3.1 SDM

Jabatan	Jumlah SDM Komite Keperawatan			Keterangan
	Standar	Kondisi Saat Ini	Kebutuhan	
Ketua Komite Keperawatan	1	1	0	Ners
Sekretaris Komite Keperawatan	1	1	0	D3 Keperawatan
Sub Komite Kredensial	1	1	0	D3 Keperawatan
Anggota Sub Komite Kredensial	1	1	0	D3 Keperawatan
Sub Komite etik dan disiplin	1	1	0	Ners
Anggota Sub Komite etik dan disiplin	1	1	0	D3 Keperawatan
Sub Komite Mutu Keperawatan	1	1	0	Ners
Anggota Sub Komite Mutu Keperawatan	1	1	0	Ners

No	Kegiatan Pokok	Rencana Kegiatan
1	Kebutuhan SDM	- Sudah terpenuhi, tidak perlu penambahan SDM.
2	Orientasi	- Melaksanakan orientasi bagi perawat baru dan perawat mutasi tentang struktur organisasi, SPO, program mutu keperawatan, dan kode etik keperawatan. - Menyusun buku panduan orientasi Komite Keperawatan.
3	Pendidikan dan Pelatihan	- Menyelenggarakan pelatihan peningkatan kompetensi (BTCLS/ACLS, Triage, asuhan keperawatan, dll) - Mengikuti workshop atau seminar profesi (internal maupun eksternal). - Menyusun rencana kebutuhan pelatihan tahunan berdasarkan hasil penilaian kompetensi.
4	Evaluasi Kegiatan	- Melakukan evaluasi kegiatan komite keperawatan setiap triwulan. - Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi perbaikan. - Menindaklanjuti hasil evaluasi kredensial dan kinerja tenaga keperawatan.

3.2 Pengembangan Pelayanan

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan
1	Inovasi dan Evaluasi Pelayanan Keperawatan	- Mengembangkan inovasi pelayanan keperawatan berbasis <i>evidence-based practice</i>. - Melakukan survei kepuasan pasien terhadap pelayanan keperawatan. - Melaksanakan evaluasi hasil implementasi inovasi dan tindak lanjut perbaikannya.

3.3 Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

Tabel 3.1 Kegiatan pokok dan rincian kegiatan Komite Keperawatan 2026

No	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1	Kredensial dan Re-kredensia	• Verifikasi dokumen STR & SIP perawat • Penilaian kompetensi awal perawat baru • Re-kredensial berkala perawat lama • Rekomendasi kewenangan klinis
2	Pembinaan dan Pengembangan SDM	• Penyusunan rencana pelatihan perawat • Pelaksanaan in-house training • Fasilitasi seminar/workshop • Evaluasi hasil pelatihan
3	Penjaminan Mutu Asuhan Keperawatan	• Audit asuhan keperawatan • Monitoring indikator mutu keperawatan • Evaluasi penerapan SOP • Tindak lanjut hasil audit
4	Etik dan Disiplin Profesi	• Sosialisasi kode etik keperawatan • Penanganan pelanggaran etik • Pembinaan perilaku professional • Sidang etik (jika ada kasus)
5	Pengembangan Praktik Profesional	• Penyusunan/ revisi SPO keperawatan • Pengembangan standar asuhan • Implementasi evidence based nursing • Monitoring penerapan praktik
6	Penelitian dan Pengembangan	• Mendorong penelitian keperawatan • Pendampingan penyusunan karya ilmiah • Publikasi hasil penelitian • Seminar hasil penelitian
7	Monitoring dan Evaluasi Kinerja	• Penilaian kinerja perawat • Evaluasi kepatuhan terhadap regulasi • Supervisi lapangan • Feedback dan perbaikan
8	Advokasi dan Perlindungan Profesi	• Pendampingan kasus hukum/etik • Koordinasi dengan manajemen RS • Perlindungan hak perawat • Sosialisasi regulasi terbaru
9	Administrasi dan Pelaporan	• Penyusunan laporan kegiatan • Dokumentasi kegiatan komite

		• Penyusunan program kerja tahunan • Evaluasi capaian program
10	Kolaborasi dan Kemitraan	• Kerjasama dengan organisasi profesi (PPNI) • Kolaborasi dengan bidang lain di RS • Partisipasi kegiatan eksternal

3.4 Sasaran

- 1. Semua pelaksanaan kegiatan yang telah di tetapkan komite keperawatan dalam hal kredensial bagi perawat dan bidan di rumah sakit dan terlaksananya program komite keperawatan setiap tahunnya.
- 2. Hasil evaluasi kinerja tim komite keperawatan dievaluasi dalam bentuk hasil laporan yang telah dibuat setiap triwulan kepada ketua komite kemudian dilaporkan ke direktur langsung
- 3. Program komite keperawatan digunakan untuk meningkatkan skill dan kemajuan SDM terutama dibagian perawat dan bidan dirumah sakit
- 4. Rincian sasaran kegiatan:

No	RINCIAN KEGIATAN POKOK	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET / STANDAR	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
1	Verifikasi dokumen STR & SIP perawat	Memastikan legalitas praktik perawat	• Seluruh perawat	Data	• 100% valid	• Tidak ada perawat tanpa STR/SIP aktif	-
2	Penilaian kompetensi awal perawat baru	Menjamin kompetensi awal	• Perawat baru	Data	• 100% dinilai	• Seluruh perawat baru lulus asesmen	-
3	Re-kredensial berkala perawat lama dan rekomendasi kewenangan klinis	Menjamin kompetensi berkelanjutan	• Perawat klinis	Data	• 100%	• Terbit rekomendasi kewenangan klinis	-
4	Penyusunan rencana pelatihan perawat Fasilitasi seminar/workshop Evaluasi hasil pelatihan	Meningkatkan kompetensi SDM	• Seluruh perawat	Dokumen	• Tersusun 1x/tahun	Dokumen program pelatihan tersedia	-
5	Pelaksanaan in-house training	Meningkatkan skill klinis	• Perawat	Kegiatan	• ≥2x/tahun	Kegiatan terlaksana sesuai jadwal	-
6	Fasilitasi seminar/workshop	Update ilmu	• Perawat	Kegiatan	• ≥2x/tahun	Perawat mengikuti kegiatan eksternal	-
7	Evaluasi hasil pelatihan	Menilai efektivitas pelatihan	• Peserta pelatihan	Data	• 100% dievaluasi	Ada laporan evaluasi	-

No	RINCIAN KEGIATAN POKOK	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET / STANDAR	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
8	Audit asuhan keperawatan	Menilai mutu pelayanan	• Unit keperawatan	Data	• $\geq 1x$ /triwulan	• Laporan audit tersedia	-
9	Monitoring indikator mutu keperawatan	Menjaga mutu layanan	• Semua unit	Data	• 100% indikator	Capaian indikator sesuai standar	-
10	Evaluasi penerapan SOP	Menjamin kepatuhan	• Unit pelayanan	Data	$\geq 85\%$	Kepatuhan SOP tercapai	-
11	Tindak lanjut hasil audit	Perbaiki mutu	• Unit terkait	Data	100% ditindaklanjuti	Ada bukti RTL	-
12	Sosialisasi kode etik keperawatan	Meningkatkan pemahaman etik	• Perawat	Kegiatan	$\geq 1x$ /tahun	Kegiatan terlaksana	-
13	Penanganan pelanggaran etik	Menjaga profesionalisme	• Perawat terkait	Kegiatan	100% kasus ditangani	Ada berita acara	-
14	Pembinaan perilaku profesional	Meningkatkan sikap profesional	• Perawat	Kegiatan	$\geq 2x$ /tahun	Ada pembinaan	-
15	Sidang etik (jika ada kasus)	Penyelesaian kasus	• Kasus etik	Kegiatan	100% kasus	Putusan sidang tersedia	-
16.	Penyusunan/ revisi SPO keperawatan Monitoring penerapan praktik	Standarisasi pelayanan	• Unit keperawatan	Dokumen	≥ 1 /tahun	SPO tersedia & disahkan	-
17	Pengembangan standar asuhan	Meningkatkan mutu	Unit pelayanan •	Dokumen	≥ 1 /tahun	Standar tersedia	-

No	RINCIAN KEGIATAN POKOK	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET / STANDAR	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
18	Implementasi evidence	Pelayanan berbasis bukti	• Unit keperawatan	Kegiatan	1 implementasi	Bukti implementasi	-
19	Monitoring penerapan praktik	Evaluasi implementasi	• Unit pelayanan	Data	≥85%	Kepatuhan tercapai	-
20	Mendorong penelitian keperawatan	Pengembangan ilmu	• Perawat	Kegiatan	≥1 penelitian	Ada penelitian	-
21	Pendampingan penyusunan karya ilmiah	Meningkatkan kualitas karya	• Perawat	Kegiatan	≥1 kegiatan	Ada bimbingan	-
22	Publikasi hasil penelitian	Diseminasi ilmu	• Perawat	Kegiatan	≥1 publikasi	Artikel terbit	-
23	Seminar hasil penelitian	Sharing ilmu	• Perawat	Kegiatan	≥1x/tahun	Seminar terlaksana	-

No	RINCIAN KEGIATAN POKOK	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET / STANDAR	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
24.	Penilaian kinerja perawat	Menilai performa	• Perawat	Data	100%	Nilai kinerja tersedia	-
25	Evaluasi kepatuhan terhadap regulasi	Menjaga kepatuhan	• Perawat	Data	≥85%	Kepatuhan tercapai	-
26	Supervisi lapangan	Pembinaan langsung	• Unit pelayanan	Kegiatan	≥1x/bulan	Supervisi terlaksana	-
27	Feedback dan perbaikan	Peningkatan mutu	• Perawat	Kegiatan	100%	Ada tindak lanjut	-
28.	Pendampingan kasus hukum/etik	Perlindungan profesi	• Perawat	Kegiatan	100% kasus	Pendampingan terlaksana	-
29	Koordinasi dengan manajemen RS	Sinkronisasi kebijakan	• Manajemen	Kegiatan	≥2x/tahun	Rapat terlaksana	-
30	Perlindungan hak perawat	Menjamin hak	• Perawat	Kegiatan	100%	Tidak ada pelanggaran	-

No	RINCIAN KEGIATAN POKOK	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET / STANDAR	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
	Sosialisasi regulasi terbaru	Update aturan	• Perawat	Kegiatan	≥1x/tahun	Sosialisasi terlaksana	-
31	Penyusunan laporan kegiatan	• Dokumentasi program	• Komite	Dokumen	• 100%	• Laporan tersedia	-
32	Dokumentasi kegiatan komite	Arsip kegiatan	• Komite	Dokumen	100%	• Dokumen lengkap	-
33	Penyusunan program kerja tahunan	Perencanaan	• Komite	Dokumen	• 1x/tahun	• Dokumen proker tersedia	-
34	Evaluasi capaian program	Menilai keberhasilan	• Komite	Data	• 100%	• Laporan evaluasi	-
35	Kerjasama dengan organisasi profesi (PPNI)	Penguatan profesi	• Komite & PPNI	Kegiatan	• ≥1x/tahun	• Kerjasama terlaksana	-

No	RINCIAN KEGIATAN POKOK	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET / STANDAR	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
36	Kolaborasi dengan bidang lain di RS	Sinergi internal	Unit RS	Kegiatan	≥2x/tahun	Kegiatan kolaborasi	-
37	Partisipasi kegiatan eksternal	Pengembangan SDM	Perawat	Kegiatan	≥2x/tahun	Keikutsertaan tercatat	-

3.5 Cara Melaksanakan Kegiatan

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
1	Verifikasi dokumen STR & SIP perawat	- Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan STR & SIP saat rekrutmen dan berkala	Administratif	Checklist, berkas	Saat rekrutmen & berkala	- Form verifikasi, copy STR/SIP	-
2	Penilaian kompetensi awal perawat baru	- Uji kompetensi melalui orientasi, preceptorship, dan penilaian skill	Observasi, uji praktik	Form penilaian	Awal masuk kerja	- Form kompetensi	-
3	Re-kredensial berkala perawat lama dan rekomendasi	- Evaluasi ulang kompetensi, review logbook dan kinerja	Review dokumen, observasi	Form kredensial	1–3 tahun	- Berita acara, rekomendasi	-

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
	kewenangan klinis						
4	Penyusunan rencana pelatihan perawat Fasilitasi seminar/workshop Evaluasi hasil pelatihan	- Identifikasi kebutuhan pelatihan dan penyusunan program tahunan	Analisis kebutuhan	Form TNA	Tahunan	- Dokumen rencana pelatihan	-
5	Pelaksanaan in-house training	- Menyelenggarakan pelatihan internal sesuai kebutuhan	Pelatihan, simulasi	PPT, modul	Berkala	- Absensi, materi, dokumentasi	-
6	Fasilitasi seminar/workshop	- Mengikutsertakan perawat dalam seminar eksternal	Partisipasi	Sertifikat, undangan	Sesuai jadwal	- Sertifikat kegiatan	-
7	Evaluasi hasil pelatihan	- Penilaian post-test dan implementasi di unit	Evaluasi	Form evaluasi	Setelah pelatihan	- Nilai, laporan evaluasi	-
8	Audit asuhan keperawatan	- Audit dokumentasi dan praktik keperawatan	Audit	Instrumen audit	Berkala	- Laporan audit	-
9	Monitoring indikator mutu keperawatan	- Pemantauan indikator mutu keperawatan	Monitoring	Dashboard, form	Bulanan	- Laporan indikator	-
10	Evaluasi penerapan SOP	- Penilaian kepatuhan terhadap SOP	Observasi	Checklist SOP	Berkala	- Laporan evaluasi	-

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
11	Tindak lanjut hasil audit	- Penyusunan rencana perbaikan	Rapat, koordinasi	Notulen	Setelah audit	- RTL (rencana tindak lanjut)	-
12	Sosialisasi kode etik keperawatan	- Penyampaian kode etik keperawatan	Sosialisasi	PPT, leaflet	Tahunan	- Absensi, dokumentasi	-
13	Penanganan pelanggaran etik	- Investigasi dan pembinaan	Klarifikasi	Form pelaporan	Insidental	- Berita acara	-
14	Pembinaan perilaku profesional	- Coaching dan mentoring	Pembinaan	Panduan	Berkala	- Catatan pembinaan	-
15	Sidang etik (jika ada kasus)	- Pelaksanaan sidang jika ada kasus	Sidang	Dokumen kasus	Insidental	- Notulen sidang	-
16.	Penyusunan/ revisi SPO keperawata Monitoring penerapan praktik	- Review dan pembaruan SPO keperawatan	Review dokumen	Draft SPO	Berkala	- Dokumen SPO	-
17	Pengembangan standar asuhan	- Penyusunan standar berbasis praktik	Workshop	Panduan	Tahunan	- Dokumen standar	-
18	Implementasi evidence	- Penerapan EBN dalam praktik	Implementasi	Jurnal, SOP	Berkala	- Laporan implementasi	-
19	Monitoring penerapan praktik	- Observasi pelaksanaan praktik	Monitoring	Checklist	Berkala	- Laporan monitoring	-
20	Mendorong penelitian keperawatan	- Motivasi dan fasilitasi penelitian	Sosialisasi	Panduan	Tahunan	- Proposal penelitian	-

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
21	Pendampingan penyusunan karya ilmiah	- Bimbingan penyusunan karya tulis	Mentoring	Template	Berkala	- Draft karya ilmiah	-
22	Publikasi hasil penelitian	- Publikasi di jurnal/seminar	Publikasi	Jurnal	Tahunan	- Artikel terbit	-
23	Seminar hasil penelitian	- Presentasi hasil penelitian	Seminar	PPT	Tahunan	- Sertifikat, dokumentasi	-
24.	Penilaian kinerja perawat	- Evaluasi kinerja perawat	Penilaian	SKP, form	Tahunan	- Hasil penilaian	-
25	Evaluasi kepatuhan terhadap regulasi	- Monitoring kepatuhan aturan	Audit	Checklist	Berkala	- Laporan evaluasi	-
26	Supervisi lapangan	- Kunjungan ke unit kerja	Supervisi	Form supervisi	Berkala	- Laporan supervisi	-
27	Feedback dan perbaikan	- Pemberian umpan balik	Diskusi	Notulen	Berkala	- Catatan perbaikan	-
28.	Pendampingan kasus hukum/etik	- Pendampingan jika ada kasus	Konsultasi	Dokumen	Insidental	- Laporan kasus	-

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
29	Koordinasi dengan manajemen RS	- Rapat koordinasi	Rapat	Notulen	Berkala	- Notulen rapat	-
30	Perlindungan hak perawat	- Advokasi hak perawat	Advokasi	Regulasi	Berkala	- Laporan kegiatan	-
	Sosialisasi regulasi terbaru	- Rekap seluruh kegiatan komite	Dokumentasi	Template laporan	Bulanan/tahunan	- Laporan kegiatan	-
31	Penyusunan laporan kegiatan	- Pengarsipan kegiatan	Dokumentasi	Foto, file	Berkala	- Arsip kegiatan	-
32	Dokumentasi kegiatan komite	- Penyusunan program tahunan	Perencanaan	Dokumen	Tahunan	- Program kerja	-
33	Penyusunan program kerja tahunan	- Analisis pencapaian program	Evaluasi	Laporan	Tahunan	- Laporan evaluasi	-
34	Evaluasi capaian program	- Koordinasi dengan PPNI	Kolaborasi	Surat	Berkala	- MoU/kegiatan	-
35	Kerjasama dengan organisasi profesi (PPNI)	- Kerjasama lintas unit	Koordinasi	Notulen	Berkala	- Laporan kegiatan	-

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
36	Kolaborasi dengan bidang lain di RS	- Mengikuti kegiatan luar RS	Partisipasi	Undangan	Sesuai jadwal	- Sertifikat	-
37	Partisipasi kegiatan eksternal	- Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan STR & SIP saat rekrutmen dan berkala	Administratif	Checklist, berkas	Saat rekrutmen & berkala	- Form verifikasi, copy STR/SIP	-

3.6 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Komite Keperawatan Tahun 2026

NO	KEGIATAN	SASARAN	BULAN												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Kredensial dan Re-kredensia	Perawat baru & lama	☑			☑			☑			☑			RS	Komite Keperawatan	RS	-
2	Pembinaan dan Pengembangan SDM	Seluruh perawat		☑			☑			☑			☑		RS	Komite & Diklat	RS	-
3	Penjaminan Mutu Asuhan Keperawatan	Unit pelayanan	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	RS	Komite & PMKP	RS	-
4	Etik dan Disiplin Profesi	Seluruh perawat	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	RS	Komite Keperawatan	RS	-
5	Pengembangan Praktik Profesional	Perawat klinis		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	RS	Komite Keperawatan	RS	-

NO	KEGIATAN	SASARAN	BULAN												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
6	Penelitian dan Pengembangan	Perawat	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	RS	Komite Keperawatan	RS	-
7	Monitoring dan Evaluasi Kinerja	Seluruh perawat		☑		☑		☑		☑		☑		☑	RS	Komite & SDM	RS	-
8	Advokasi dan Perlindungan Profesi	Perawat			☑			☑			☑			☑	RS	Komite Keperawatan	RS	-
9	Administrasi dan Pelaporan	Komite	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	RS	Sekretaris Komite	RS	-
10	Kolaborasi dan Kemitraan	Internal & eksternal		☑			☑			☑			☑		RS/Luar	Komite Keperawatan	RS	-

3.7 Kebutuhan Anggaran

Anggaran biaya berdasarkan rata-rata pemakaian:

NO	Kegiatan	BAHAN	RATA /BULAN	KEBUTUHAN 1 TAHUN	HARGA SATUAN	TOTAL	KET
1	Kredensial & Re-kredensial	ATK, map, fotokopi	50 lbr	600 lbr	500	300.000	-
	Penjaminan Mutu	Form audit	30 lbr	360 lbr	-	-	Form elektronik
	Etik & Disiplin Profesi	Leaflet, Form, ATK	5 lbr	60 lbr	500	30.000	-
	Pengembangan Praktik Profesional	Cetak SPO, buku panduan	10 buku	120 buku	-	-	Elektronik
	Penelitian & Pengembangan	ATK, TOR	10 lbr	120 lbr	-	-	Soft copy

NO	Kegiatan	BAHAN	RATA /BULAN	KEBUTUHAN 1 TAHUN	HARGA SATUAN	TOTAL	KET
	Monitoring & Evaluasi	Form supervisi	30 lbr	360 lbr	-	-	Form elektronik
	Advokasi & Perlindungan Profesi	Konsumsi rapat	1 keg	12 keg	1.000	120.000	-
	Administrasi & Pelaporan	Form Laporan	1 paket	12 paket	-	-	Soft copy
	Kolaborasi & Kemitraan	Transport, konsumsi	1 keg	12 keg	-	-	Driver RS

Anggaran Kebutuhan Biaya Pengembangan SDM Komite Keperawatan Tahun 2026

No	Kegiatan/Rincian Kegiatan	Internal/Eksternal	Jumlah (Satuan)	Harga Satuan	Total
1	Pelatihan Patient Safety	Internal	1 paket	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
3	Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD)	Internal	1 paket	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
4	Pelatihan Komunikasi SBAR	Internal	1 paket	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
5	Pelatihan Asuhan Keperawatan (SDKI, SLKI, SIKI)	Internal	1 paket	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000
6	Pelatihan Manajemen Nyeri	Internal	1 paket	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000
7	Pelatihan Audit Keperawatan & Indikator Mutu	Internal	1 paket	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000
8	Pelatihan Kode Etik & Legal	Internal	1 paket	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000
9	Pelatihan Evidence Based Nursing Practice	Internal	1 paket	Rp 3.500.000	Rp 3.500.000
TOTAL					Rp 24.000.000

Semua anggaran akan dibiayai dari anggaran Rumah Sakit Prima Husada Malang yang telah disetujui oleh PT Disa Prima Medika.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

8.1 Monitoring

Monitoring kegiatan dilaksanakan setiap waktu secara berjenjang mulai dari unit sendiri (perawat pelaksana), kepala ruang, komite keperawatan, dan seterusnya. Monitoring dilakukan secara rutin dan dilakukan pencatatan pada form monitoring yang nantinya akan dilaporkan kepada ketua Komite Keperawatan dan Direksi. Pada saat monitoring dilakukan tindak lanjut secara langsung atas temuan yang dapat langsung dilakukan tindak lanjutnya.

8.2 Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan setiap akhir pelaksanaan kegiatan dan evaluasi program dilaksanakan pada akhir tahun.

Evaluasi dilakukan pula dalam bentuk rapat rutin yang dilakukan oleh Komite sebagai berikut:

- a. Rapat Komite Keperawatan setiap 1 bulan sekali mengadakan rapat dengan seluruh anggota Komite Keperawatan untuk menyampaikan hasil laporan dan bersama-sama menjalankan tindak lanjutnya.
- b. Rapat Koordinasi Antar Komite setiap 3 bulan sekali mengadakan rapat dengan Komite lainnya (PMKP, K3RS, Tim PKRS, PPRA, Komite PPI dan Nakes lain) dan manajemen untuk menyampaikan hasil laporan dan bersama-sama menentukan tindak lanjutnya.
- c. Rapat Koordinasi Manajemen / antar unit isidentil dengan Karu dan manajemen untuk menyampaikan hasil laporan temuan untuk bersama-sama menentukan tindak lanjutnya.

Dokumentasi kegiatan dilakukan pada saat akhir kegiatan dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan yang meliputi TOR, Laporan pelaksanaan, UMANDOK.

BAB V

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Upaya peningkatan kualitas perawatan di RS Prima Husada tidak bisa diwujudkan hanya dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan saja, akan tetapi dibutuhkan upaya peningkatan sistem dan pemikiran yang holistik. Evaluasi kegiatan yang dilakukan dalam upaya peningkatan keperawatan dilakukan di semua unit kerja. Evaluasi kegiatan dilakukan sebagai berikut:

- a. Setiap 3 bulan Ketua Sub Komite membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan hasil monitoring dilaporkan ke Ka Komite Keperawatan paling lambat tanggal 5.
- b. Setiap 3 bulan Ka Komite Keperawatan membuat analisa pelaksanaan kegiatan dan hasil monitoring dilaporkan ke Direktur.
- c. Setiap 6 bulan Ka Komite Keperawatan membuat Analisa pelaksanaan kegiatan dan hasil monitoring dilaporkan kepada Direktur.
- d. Laporan evaluasi tahunan pelaksanaan program disampaikan pada awal tahun berikutnya paling lambat tanggal 10 Januari.

Agar proses pelaksanaan program keperawatan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya, maka proses pelaksanaan kegiatan didokumentasikan dan dicatat setiap bulan oleh Komite keperawatan.

BAB VI PENUTUP

Program kerja ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan keperawatan RS Prima Husada Malang. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat meningkatkan mutu pelayanan keperawatan RS Prima Husada Malang.

Malang, 27 November 2025
Ketua Komite Keperawatan



Fariz Tiarawan Fadil C, S. Kep., Ns

Disusun oleh,
Sekretaris Komite Keperawatan



Lola Novira Risdiyanti, AMd. Kep

Mengetahui,
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes